

CAPÍTULO 13.56

Cuerpo Extraño Laringeo y Bronquial

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **cuerpo extraño (CE) en la vía aérea** es una de las emergencias médicas más críticas, especialmente en la población pediátrica. La rapidez en el diagnóstico y la ejecución de las maniobras de desobstrucción pueden determinar la supervivencia del paciente. Clínicamente, se divide según su ubicación en **laringeo** (vía aérea superior) y **bronquial** (vía aérea inferior).

1. Cuerpo Extraño Laríngeo (Obstrucción de Vía Aérea Superior)

Es una urgencia extrema. La laringe es el punto más estrecho de la vía aérea superior en niños, por lo que un objeto impactado aquí puede causar una **obstrucción completa** y la muerte inmediata por asfixia.

Clínica de la Obstrucción

Es fundamental diferenciar entre una obstrucción total y una parcial para determinar el manejo:

- **Obstrucción Total (Signos de alarma):**
 - Imposibilidad de hablar, llorar o toser.
 - Incapacidad para respirar.
 - Signo universal de asfixia (manos al cuello).
 - Cianosis rápida y pérdida de conciencia.
- **Obstrucción Parcial (No obstructivo):**
 - El paciente **puede hablar**, toser con fuerza o llorar.
 - Si el paciente dice "me estoy ahogando", significa que está movilizándolo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡CUIDADO! Si el paciente tiene una obstrucción parcial (puede hablar o toser), **NO** se debe realizar la maniobra de Heimlich. El movimiento brusco podría desplazar el objeto y convertir la obstrucción en total. En estos casos, se debe calmar al paciente, fomentar la tos espontánea y derivar de inmediato a un servicio de urgencia para extracción bajo visión directa.

Manejo de la Obstrucción Total

El tratamiento de elección depende de la edad del paciente:

TABLA 13.56.1: GRUPO ETARIO VS MANIOBRA DE ELECCIÓN

GRUPO ETARIO	MANIOBRA DE ELECCIÓN	TÉCNICA
Menores de 1 año (Lactantes)	Golpes interescapulares y compresiones torácicas	5 golpes en la espalda (boca abajo) + 5 compresiones en el tórax (boca arriba). Repetir hasta que salga el objeto o el niño pierda la conciencia.
Mayores de 1 año y Adultos	Maniobra de Heimlich	El reanimador se sitúa detrás del paciente, abraza su cintura y coloca el puño bajo la apófisis xifoides, presionando con fuerza hacia atrás y hacia arriba (en forma de "J").
Pacientes Obesos o Embarazadas	Compresiones torácicas	Si el diámetro abdominal impide el Heimlich, se realizan compresiones en el centro del esternón.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente con obstrucción total pierde la conciencia, se debe iniciar de inmediato el protocolo de **RCP básico**, ya que las compresiones torácicas generan una presión intratorácica que puede ayudar a expulsar el cuerpo extraño.

2. Cuerpo Extraño Bronquial (Vía Aérea Inferior)

Es más frecuente que el laringeo y suele presentarse en niños pequeños que aspiran alimentos (frutos secos) o piezas pequeñas de juguetes.

El Síndrome de Penetración

Es el evento inicial clave en la anamnesis. Se define como un episodio brusco de **tos súbita, intensa y en accesos** (paroxística) mientras el niño comía o jugaba.

- A menudo, tras este episodio inicial, hay un "periodo de silencio" donde la tos disminuye, lo que puede llevar a los padres a pensar que el peligro pasó.
- En muchos casos, el accidente no es presenciado por adultos, lo que retrasa el diagnóstico.

Cuadro Clínico Posterior

Si el CE no se extrae, el paciente puede evolucionar con: - Tos persistente o crónica. - **Neumonía recurrente** en el mismo lóbulo. - **Asma de difícil manejo:** Sospechar siempre un cuerpo extraño en un niño con sibilancias que no responde al tratamiento broncodilatador habitual. - **Examen Físico:** Disminución localizada del **murmulo pulmonar**, sibilancias localizadas y, a veces, crépitos.

NOTA CLÍNICA

Anatomía: El lugar más frecuente de impactación es el **bronquio fuente derecho**. Esto se debe a que el bronquio derecho es más vertical, más corto y de mayor calibre que el izquierdo, siguiendo la dirección de la tráquea y facilitando el paso de objetos por gravedad.

3. Diagnóstico por Imágenes

Ante la sospecha de un CE bronquial, el estudio inicial es la **Radiografía de Tórax** (en inspiración y espiración si es posible).

Hallazgos Radiológicos

Dependen de si el objeto es radiopaco o radiolúcido y del grado de obstrucción:

- **Cuerpo Extraño Radiopaco:** Se ve directamente el objeto (monedas, pilas, piezas metálicas). Solo ocurre en el 10-20% de los casos.
- **Cuerpo Extraño Radiolúcido (Orgánicos):** No se ve el objeto, pero se ven sus efectos indirectos:
 - **Enfisema obstructivo (Hiperinsuflación):** Ocurre por un "efecto valvular" (el aire entra pero no sale). Se observa un pulmón o lóbulo más negro y con aumento de volumen.
 - **Atelectasia:** Ocurre por obstrucción completa. El aire distal se absorbe y el pulmón se colapsa.
 - **Desviación del mediastino:** En espiración, el mediastino se aleja del lado afectado si hay hiperinsuflación.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Una radiografía normal **NO** descarta un cuerpo extraño si la sospecha clínica es alta. Si la clínica manda, el siguiente paso es la **broncoscopia**.

4. Manejo Definitivo

El estándar de oro tanto para el diagnóstico definitivo como para el tratamiento es la **Broncoscopia**.

- **Broncoscopia Rígida:** Es la técnica de elección para la extracción de cuerpos extraños en pediatría, ya que permite un mejor control de la vía aérea y el uso de pinzas especializadas.
- **Broncoscopia Flexible:** Útil para diagnóstico en casos dudosos o cuando el CE está en bronquios muy distales.

Resumen de la Conducta

1. **Sospecha clínica clara (Síndrome de penetración):** Ir directo a broncoscopía, incluso con Rx normal. 2. **Duda diagnóstica:** Se puede solicitar una **Tomografía Computarizada (TAC)** de tórax, que tiene alta sensibilidad para detectar objetos radiolúcidos. 3.

Extracción: Siempre debe realizarse en un entorno controlado (pabellón) por especialistas (broncopulmonares o cirujanos infantiles).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca intente extraer un cuerpo extraño a ciegas con los dedos (barrido digital), ya que esto puede empujar el objeto más profundamente o causar un edema laríngeo que agrave la situación.

- **Enlaces relacionados:**
- **Insuficiencia Respiratoria**
- **Sibilancias en el Pediatra**
- **Paro Cardiorespiratorio**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un niño de 2 años es encontrado por su madre con dificultad respiratoria súbita, sin capacidad de llorar ni toser, mientras jugaba con piezas pequeñas. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cuerpo Extranño Laringeo y Bronquial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El cuerpo extraño laringeo obstructivo es una urgencia vital con imposibilidad de respirar, hablar, llorar o toser
- Maniobra de Heimlich: de elección desde 1 año de edad en adelante para obstrucción completa
- Menores de 1 año: 5 golpes interescapulares alternando con 5 compresiones torácicas
- En obstrucción parcial (no obstructivo) NO hacer Heimlich; derivar a urgencias para extracción con laringoscopia
- El síndrome de penetración es la clínica clásica del cuerpo extraño bronquial: tos súbita e intensa que luego cede
- Localización más frecuente del cuerpo extraño bronquial: lóbulo inferior derecho
- La radiografía de tórax se solicita siempre, independiente de si es radiopaco o radiolucido
- Signos radiológicos del cuerpo extraño radiolucido: atelectasia o hiperinsuflación localizada
- La broncoscopia es diagnóstica y terapéutica para el cuerpo extraño bronquial

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CUERPO EXTRAÑO LARINGEO Y BRONQUIAL)**PREGUNTA 1**

Un niño de 2 años es encontrado por su madre con dificultad respiratoria súbita, sin capacidad de llorar ni toser, mientras jugaba con piezas pequeñas. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

- A)** Realizar maniobra de Heimlich con compresiones subdiafrágicas
- B)** Llamar al servicio de emergencias y esperar sin intervenir
- C)** Colocar al niño boca abajo y dar 5 golpes interescapulares, alternando con 5 compresiones torácicas
- D)** Realizar compresiones torácicas como en reanimación cardiopulmonar
- E)** Intentar extraer el cuerpo extraño con los dedos a través de la boca

PREGUNTA 2

Un niño de 4 años consulta por tos persistente de 2 semanas de evolución que no responde al tratamiento con broncodilatadores. La madre refiere un episodio de tos súbita e intensa mientras comía, hace 3 semanas, que luego cedió espontáneamente. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Asma bronquial de difícil manejo
- B)** Neumonía del lóbulo inferior derecho
- C)** Cuerpo extraño bronquial en bronquio derecho
- D)** Neumotorax espontáneo derecho
- E)** Bronquiolitis viral aguda

PREGUNTA 3

Un adulto joven está comiendo en un restaurante y comienza a hacer señas de ahogamiento, no puede hablar ni toser, y se lleva las manos al cuello. Otro comensal intenta ayudarlo pero el paciente es extremadamente obeso y no logra rodearlo con sus brazos. ¿Cuál es la alternativa correcta?

- A)** Dar golpes interescapulares con el paciente de pie e inclinado hacia adelante
- B)** Acostar al paciente en el suelo y realizar compresiones abdominales subdiafrágicas en dirección cefálica
- C)** Esperar a que llegue el servicio de emergencias sin intervenir
- D)** Intentar extraer el cuerpo extraño con los dedos realizando barrido digital
- E)** Realizar ventilación boca a boca para forzar la entrada de aire

RESUMEN: CUERPO EXTRAÑO LARINGEO Y BRONQUIAL

Esta clase aborda el manejo del cuerpo extraño en vía aérea, diferenciando entre la localización laringea y la bronquial. El cuerpo extraño laringeo es una urgencia vital, ya que puede producir obstrucción completa de la vía aérea con imposibilidad de respirar, hablar, llorar o toser. Si el paciente puede hablar o toser, se trata de una obstrucción no completa y el manejo cambia. En el cuerpo extraño laringeo obstructivo, la maniobra de Heimlich es el tratamiento de elección desde el año de edad en adelante, realizando compresiones subdiafrágicas. En menores de un año, se realizan 5 golpes interescapulares con el bebé boca abajo, alternando con 5 compresiones torácicas. En pacientes obesos que no permiten la maniobra de Heimlich de pie, se realizan compresiones en el suelo. Si la obstrucción es parcial (no obstructiva), no se realiza Heimlich por riesgo de desplazar el cuerpo extraño y convertirlo en obstructivo; se deriva a urgencias para extracción mediante laringoscopia. El cuerpo extraño bronquial se presenta clásicamente con el síndrome de penetración: tos súbita e intensa que luego cede parcialmente. Es frecuente en niños sin testigos. Posteriormente aparece tos persistente, clínica de neumonía o asma de difícil manejo. La localización más frecuente es el lóbulo inferior derecho, por la anatomía del bronquio derecho que es más recto. La radiografía de tórax es fundamental: si es radiopaco se ve directamente; si es radiolucido puede mostrar atelectasia o hiperinsuflación localizada. La broncoscopia es el método diagnóstico y terapéutico de elección.